



주요 약물

✓ Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)

- escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline 등이 있다.
- TCA에 비해 항콜린성 부작용, 진정 효과 등의 부작용이 적다.

✓ Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI)

- desvenlafaxine, duloxetine, milnacipran, venlafaxine 등이 있다.
- 통증 및 신체 증상 감소에 효과가 있다.

✓ Mirtazapine

- 불면, 식욕 및 체중 감소, 불안 증상 감소에 효과가 있다

✓ Agomelatine

- 수면시간 및 질의 향상에 효과가 있다.

✓ Bupropion

- 정신운동지체, 피로감, 집중력 저하를 개선하는 효과가 있다.

✓ Vortioxetine

- 인지기능 보존 및 향상에 효과가 있다.

✓ Tri- or tetra-cyclic antidepressants (이하 TCA)

- 우울증상의 치료에 효과가 있으나 약물 부작용으로 인해 낮은 선호도를 가진다.

항우울제 권고 요약표

항우울증약	기전	용량(mg)
제1차 약제		
agomelatine	MT1 and MT2 agonist; 5-HT2 antagonist	25-50
bupropion	NDRI	150-300
citalopram	SSRI	20-40
desvenlafaxine	SNRI	50-100
duloxetine	SNRI	60
escitalopram	SSRI	10-20
fluoxetine	SSRI	20-60
fluvoxamine	SSRI	100-300
milnacipran	SNRI	100
mirtazapine	α 2-Adrenergic agonist; 5-HT2 antagonist	15-45
paroxetine	SSRI	20-50
sertraline	SSRI	50-200
venlafaxine	SNRI	75-225
vortioxetine	Serotonin reuptake inhibitor; 5-HT1A agonist; 5-HT1B partial agonist; 5-HT1D, 5-HT3A, and 5-HT7 antagonist	10-20
제2차 약제		
amitriptyline	TCA	30-300
imipramine	TCA	25-200
nortriptyline	TCA	10-150
trazodone	Serotonin reuptake inhibitor; 5-HT2 antagonist	150-300
monoclobemide	Reversible inhibitor of MAO-A	300-600



I 특정 상황에서 항우울제 선택

부작용을 고려한 항우울제 선택

	선택약물
성기능 장애	Bupropion, Mirtazapine, Vortioxetine
졸리움, 진정작용	Bupropion, Fluoxetine, Tianeptine
체중증가	Bupropion, Fluoxetine, Vortioxetine
수면장애(불면)	Mirtazapine, Paroxetine, TCAs
소화기장애(오심/구토)	Mirtazapine, Tianeptine, Bupropion
항콜린성 부작용	Escitalipram, Agomelatine, Vortioxetine

안정성을 고려한 항우울제 선택

	선택약물
안전사고	Bupropion, Escitalipram, Fluoxetine
세로토닌증후군	Bupropion, Tianeptine, Agomelatine
기질성 저혈압	Bupropion, Escitalipram, Mirtazapine
자살사고	Mirtazapine, Bupropion, Agomelatine

공존 신체질환을 고려한 항우울제 선택

	선택약물
당뇨병	Escitalipram, Sertraline, Bupropion
갑상선 질환	Escitalipram, Sertraline, Fluoxetine
간질환	Escitalipram, Sertraline, Tianeptine
신장질환	Escitalipram, Sertraline, Tianeptine
고혈압	Escitalipram, Sertraline, Tianeptine
뇌전증	Escitalipram, Sertraline, Tianeptine
심혈관질환	Sertraline, Escitalipram, Tianeptine
파킨슨병	Escitalipram, Sertraline, Bupropion
부정맥	Sertraline, Escitalipram, Fluoxetine
만성통증	Duloxetine, Milnacipran, Venlafaxine

I 진료의뢰 기준

- 임상적으로 우울증이 의심되는 환자
- PHQ-2 선별검사 (+)

환자 위험도 평가

- 자타해 위험성 평가
- 자살시도의 과거력
- 정신병적 증상 및 현실 검증력

응급실 방문 혹은
입원기관으로 연계

초기 평가

- 우울증의 심각도 : 중증*
- 정신건강의학과 공존질환: 물질사용장애, 양극성장애, 정신병적 장애
- 특수집단 : 소아/청소년, 주산기 우울증, 노인성 치매

정신건강의학과
클리닉 연계

급성기 치료

- 행동활성화기법
- 상담
- 생활습관개선
- 운동요법
- 환자교육
- 약물치료(SSRI 등)

치료반응 평가(4주~8주)

- 초기에 비하여 50% 이하의 불충분한 치료 반응의 경우
- PHQ-9 초기 총점보다 5점 미만으로 감소한 경우

정신건강의학과
클리닉 연계

지속치료 필요성 평가

- 두 번 이상의 우울증 삽화가 존재하거나 약물을 감량한 경우
- 중단 시 재발가능성이 높아서 유지치료가 필요한 경우

*중증 : PHQ-9 선별검사 점수가 20점 이상이거나 DSM-5 진단기준 9가지 중 7가지 이상을 만족하고
직업적·사회적 기능저하가 현저한 경우